



*POST GAD

COR SE

SCTIME 1:45

205*256

NSA 2 M

TR 409

TE 15

FOV 250

THK 5.0/ 1.0

SLICE 9/ 15

ANT 8.6

LEFT -2.9

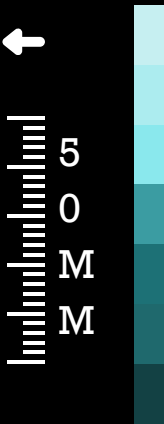
CAUD -15.5



07/12/2025

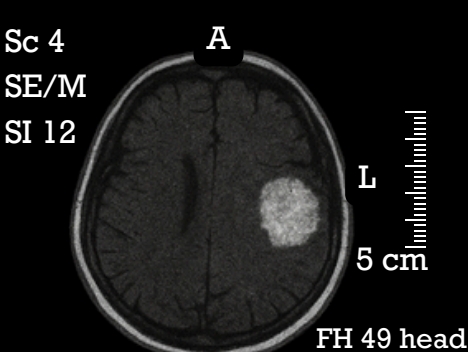
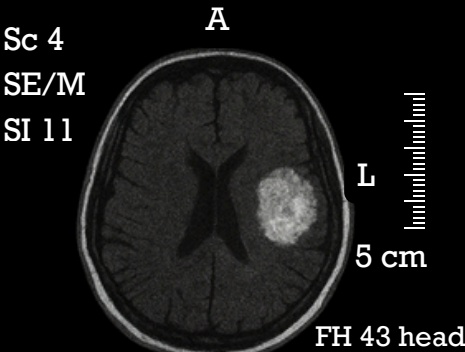
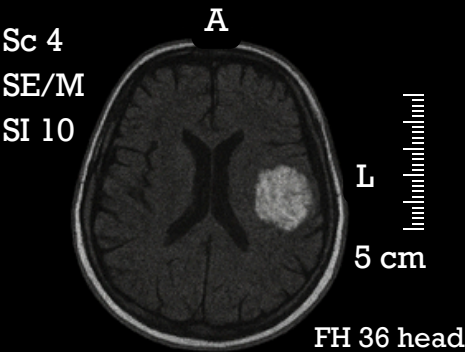
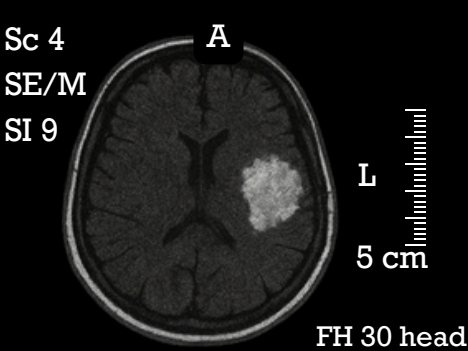
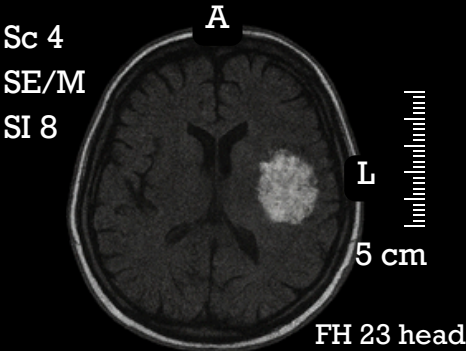
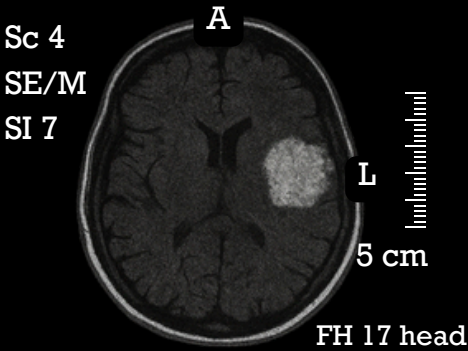
1:02

SCAN 9



L W 1079

L 775



OBJET DU RAPPORT: IRM CÉRÉBRALE

Dimanche 7 décembre 2025

TECHNIQUE

Séquences pondérées en T1, T2, FLAIR, DWI, SWI, T2* et T1 avec injection de gadolinium, reconstructions multiplanaires.

RÉSULTATS

- Présence d'une contusion cérébrale fronto-pariétale droite avec hypersignal hétérogène en FLAIR.
- Hématome sous-dural mince homolatéral (épaisseur estimée à 5 mm), sans effet de masse significatif.
- Micro-hémorragies corticales visibles en SWI, en rapport avec un traumatisme crânien à haute cinétique.
- Légère hyperfocalisation en diffusion compatible avec un œdème contusionnel localisé.
- Pas d'engagement, pas d'hydrocéphalie.
- Structures sus- et sous-tentorielles respectées en dehors des lésions décrites.

CONCLUSION DE L'IRM CÉRÉBRALE

Traumatisme crânien important :

- Contusion cérébrale fronto-pariétale droite.
- Fin liseré d'hématome sous-dural sans retentissement sur la ligne médiane.
- Micro-hémorragies traumatiques diffuses.

LA PATIENTE A ÉTÉ PRISE EN CHARGE PAR :

- Perfusion intraveineuse d'antalgiques morphiniques.
- Administration IV d'agents anti-œdémateux manitol solutés hypertoniques pour limiter l'hypertension intracrânienne.
- Perfusion de médicaments favorisant la résorption de l'hématome (corticothérapie).
- Surveillance neurologique rapprochée en milieu hospitalier.

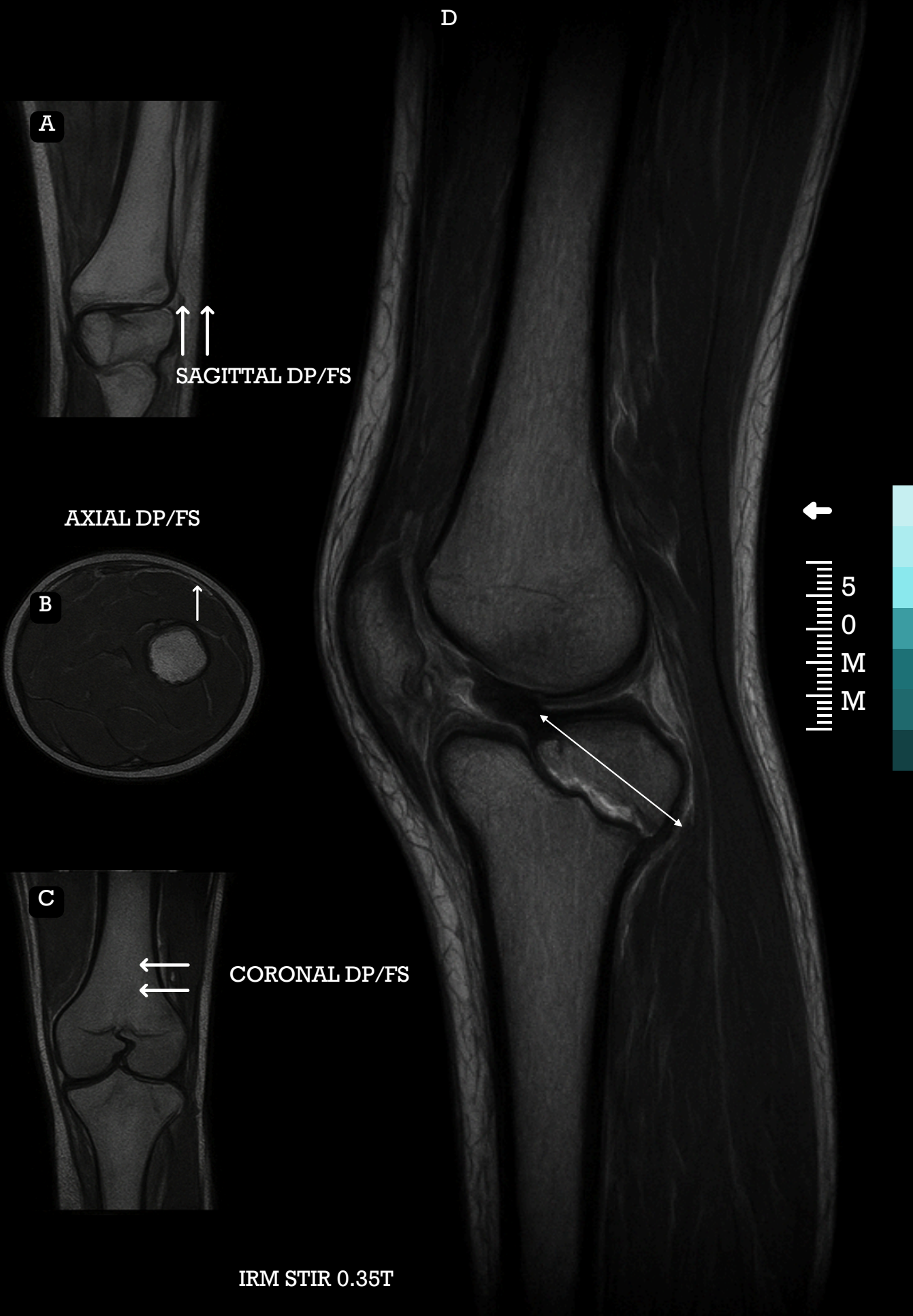
Pronostic réservé à court terme nécessitant surveillance continue.

Médecin : Dr. Miller Amber

Spécialité : Chef de Service Psychologie & Médecin Urgentiste

Téléphone : 555-2483

A. Miller



OBJET DU RAPPORT: IRM DES MEMBRES INFÉRIEURS

Dimanche 7 décembre 2025

TECHNIQUE

Séquences T1, T2, STIR, T2FS, avec et sans injection de gadolinium.

RÉSULTATS

- Fracture transversale non déplacée du tibia droit, bien visible en T1 et STIR, sans atteinte articulaire.
- Hématomes sous-cutanés étendus des faces antérieure et latérale des deux jambes.
- Infiltration œdémateuse des muscles jumeaux internes, plus marquée à droite, sans rupture.
- Pas de collection profonde, ni atteinte vasculaire visible.
- Intégrité de la fibula et des éléments ligamentaires examinés.

CONCLUSION DE L'IRM CÉRÉBRALE

Fracture tibiale droite non déplacée.

- Contusions des tissus mous bilatérales avec hématomes étendus.
- Myosite traumatique modérée sans déchirure musculaire.

LA PATIENTE A BÉNÉFICIÉ

- D'une immobilisation du membre inférieur droit avec résine.
- D'une analgésie intraveineuse par perfusion continue.
- De la mise en place d'un traitement hématome-réducteur à base d'agents anti-inflammatoires IV.
- De mesures adjuvantes : glaçage intermittent, repos strict et élévation du membre.

Médecin : Dr. Miller Amber

Spécialité : Chef de Service Psychologie & Médecin Urgentiste

Téléphone : 555-2483

A. Miller

